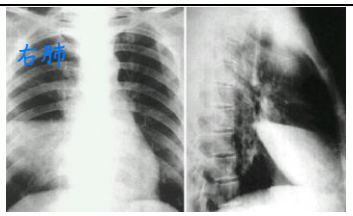
X 线或 CT **大叶性实变影** **支气管充气征**	 右肺分上中下叶 （右肺中叶大叶性肺炎）  （支气管充气征：大叶性肺炎累及肺泡、不累及支气管，含气的支气管被实变的肺泡衬托）
绝无空洞	①肺炎链球菌不产生毒素→不导致肺组织坏死，经治疗后病变消散、肺组织结构多**没有损坏** VS 干酪性肺炎一定有空洞 ②肺炎链球菌靠**荚膜**致病（肉夹馍）：荚膜抗原会诱发机体产生免疫应答→建立牢固的特异性免疫→同型菌的二次感染少见
治疗首选 **青霉素** 大部分球菌都是G+ （脑膜炎奈瑟菌是G-）	①若青霉素耐药用**喹诺酮、头孢噻肟、头孢曲松**（边塞的松鼠耐冻） ②若**休克（重症肺炎）先补液** 三代头孢主要覆盖G-，但头孢噻肟、头孢曲松对肺炎链球菌敏感 ③若经抗菌药治疗 3 天后体温仍不降、或降而复升→并发肺外感染（脓胸、心包炎、关节炎等）干扰：细菌耐药❌

小凯笔记补充 抗感染治疗一般于退热2-3天且呼吸道症状明显改善后停药 VS吸入性肺脓肿停药指征看影像学

（二）金葡菌肺炎 与血源性肺脓肿是一个疾病的不同阶段

1.临床表现（层粘连蛋白受体，易侵犯血管）HAP常常都有脓痰

①脓痰带血。血源性葡萄球菌肺炎较少咳脓性痰 更多的是原发灶引起的全身脓毒症表现

②**糖尿病、痈、骨髓炎、住院频繁用抗生素**等多见 易耐药

③急性起病，寒战高热，血 WBC↑

2.影像学 靠近胸膜破溃：脓液进入胸膜腔

①**多发易变结节、空洞、液气囊腔（可致脓气胸）**不同病程

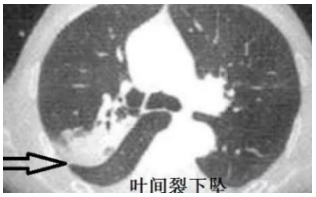
②肺炎中**最易**形成空洞，斑片或实变影 影像学里看到空洞优先考虑红绿黄臭

3.治疗 耐酶青霉素 一/二代头孢 金黄色葡萄球菌

①**苯唑西林、氯唑西林**或头孢呋辛（本座喝葡萄糖酸锌）

②耐甲氧西林金葡菌 **MRSA 用多肽类——万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺**（历来替考的太太万古长青）或头孢洛林（五代洛克人）三四代头孢只能覆盖铜绿假单胞菌

（三）克雷伯杆菌肺炎



1.主要导致小叶性肺炎

2.临床表现

①痰：**砖红色胶冻状**